

REHABILITACIÓN EN REUMATOLOGÍA

Reumatismos extra articulares –
Partes blandas

Lic. Cesar Borja Arenas

Presente.



Reconocer las principales características clínicas de los reumatismos de partes blandas más comunes y los lineamientos para el apoyo en los programas de tratamiento fisioterapéutico.

Semana 09: Reumatismos extra articulares (partes blandas)

1. Codo (epitrocleitis y epicondilitis)
2. Cadera (bursitis trocantérea)
3. Rodilla (tendinitis/bursitis anserina y rotuliana)
4. Pie (fascitis plantar)

Presente.

Articulación del codo





Epitrocleitis

“Codo de golfista.
Lesión de tendones que
se insertan en la
epitróclea del húmero
(cara medial del codo).”

Dolor local en epitróclea con posible irradiación a cara antero interna del antebrazo.

Aumento de tono muscular en musculatura flexora de muñeca y dedos.

Disminución del rango de movimiento del codo y fuerza muscular

Disminuir dolor e inflamación

- Termoterapia en cara anterior de antebrazo
- Crioterapia en zona epitrocLEAR
- Terapia combinada en zona epitrocLEAR y cara anterior de antebrazo

Aumentar rango articular (flexibilidad)

- Masoterapia sobre musculatura flexora de muñeca y dedos
- Estiramientos osteomusculares en extensión de muñeca y dedos
- Movilizaciones articulares en codo y muñeca

Incrementar fuerza muscular

- Ejercicios libres contra gravedad de flexión de muñeca
- Ejercicios isométricos en posición neutra de muñeca
- Ejercicios resistidos progresivos para flexión de muñeca (pesas, bandas, etc.)

Mejorar la funcionalidad de codo y muñeca

- Potenciar alcances combinando flexo extensión de codo
- Actividades con apoyo en extensión del brazo lesionado
- Ejercicios o actividades que impliquen el uso de pronosupinación (aros)



Epicondilitis

“Codo de tenista.
Lesión de tendones que
se insertan en el
epicóndilo del húmero
(cara lateral del codo).”

Dolor local en epicóndilo con posible irradiación a cara postero externa del antebrazo.

Aumento de tono muscular en musculatura extensora de muñeca y dedos.

Disminución del rango de movimiento del codo y fuerza muscular

Disminuir dolor e inflamación

- Termoterapia en cara posterior de antebrazo
- Crioterapia en zona del epicóndilo
- Terapia combinada en zona de epicóndilo y cara posterior de antebrazo

Aumentar rango articular (flexibilidad)

- Masoterapia sobre musculatura extensora de muñeca y dedos
- Estiramientos osteomusculares en flexión de muñeca y dedos
- Movilizaciones articulares en codo y muñeca

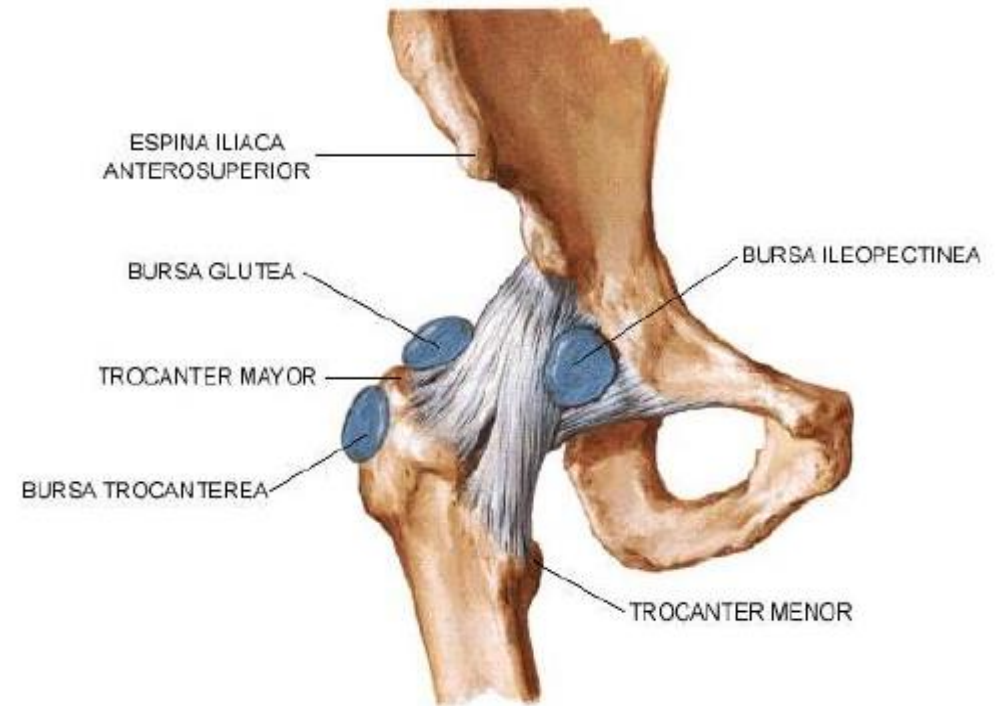
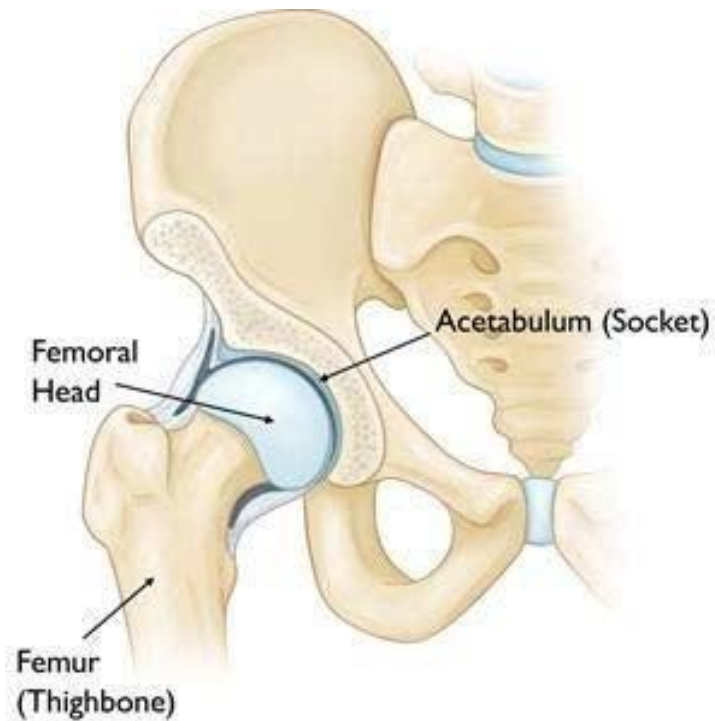
Incrementar fuerza muscular

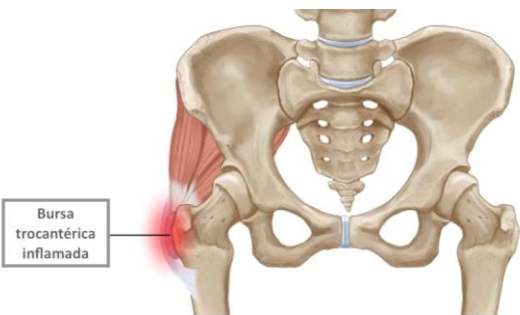
- Ejercicios libres contra gravedad de extensión de muñeca
- Ejercicios isométricos en posición neutra de muñeca
- Ejercicios resistidos progresivos para extensión de muñeca (pesas, bandas, etc.)

Mejorar la funcionalidad de codo y muñeca

- Potenciar alcances combinando flexo extensión de codo
- Actividades con apoyo en extensión del brazo lesionado
- Ejercicios o actividades que impliquen el uso de pronosupinación (aros)

Articulación de la cadera





Bursitis trocantérea

“Inflamación de la bursa o bolsa serosa ubicada en el trocánter mayor”

Dolor e inflamación local sobre trocánter mayor y posible irradiación en zona lateral del muslo

Disminución de los movimientos de cadera (sobre todo la aducción-abducción)

Aumento de tono muscular en musculatura glútea, isquiotibiales y tensor de la fascia lata

Disminuir dolor e inflamación

- Termoterapia en cara lateral-posterior del muslo y zona glútea (no sobre trocánter)
- Crioterapia en zona trocantérea
- Terapia combinada en zona trocantérea y recorrido de la banda iliotibial

Aumentar rango articular (flexibilidad)

- Masoterapia sobre musculatura isquiotibial, glútea y tensor de la fascia lata
- Estiramientos osteomusculares para cadena posterior y tensor
- Movilizaciones pasivo asistidas de la cadera (rotaciones)

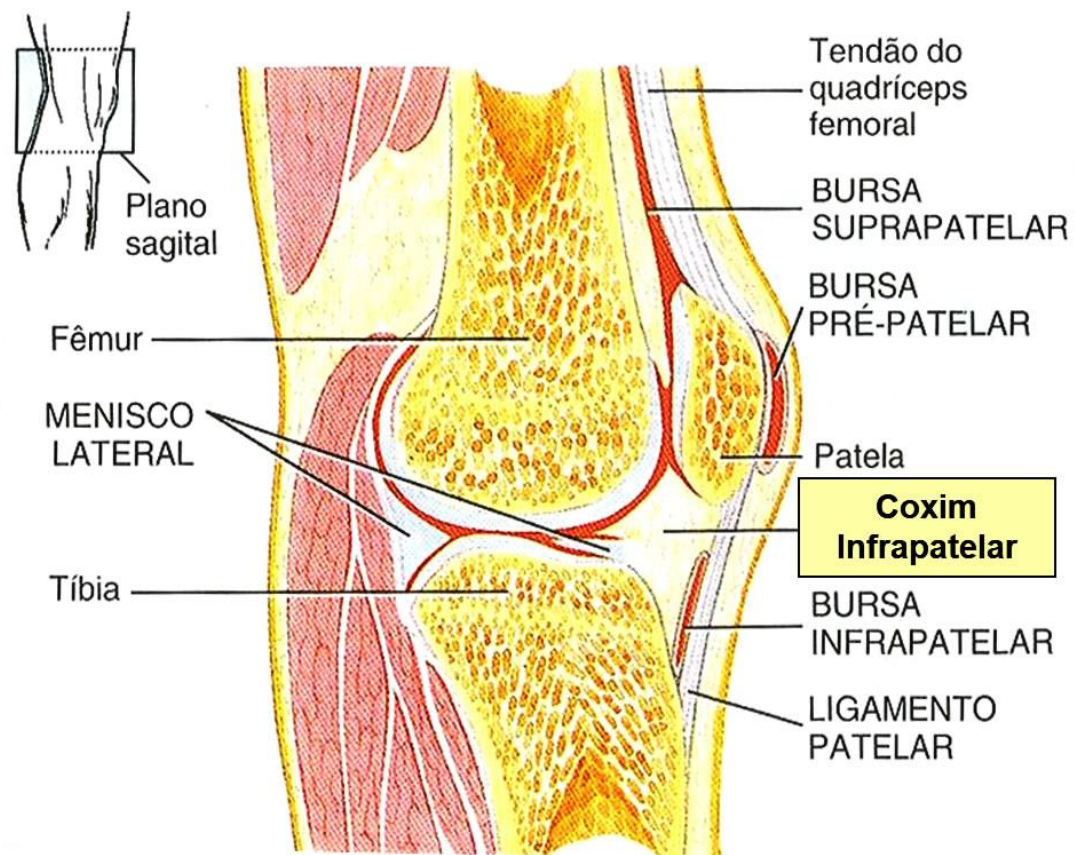
Incrementar fuerza muscular

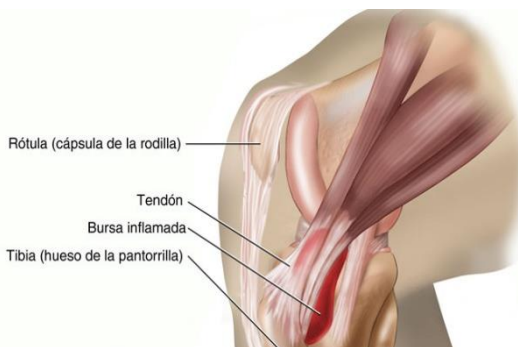
- Ejercicios libres de movimientos de cadera (supino)
- Ejercicios isométricos (actividad puente con pelota entre rodillas, sentadilla isométrica, etc.)
- Ejercicios resistidos progresivos con uso de bandas o pesas

Mejorar la funcionalidad de cadera

- Potenciar el apoyo unipodal alternado
- Mejorar la movilidad de la pelvis en actividades funcionales (alcance)
- Ejercicios de sedente a bípedo, cuclillas y bípedo, etc.

Articulación de la rodilla





Tendinitis – bursitis anserina

“Inflamación del tendón
conjunto de los músculos
grácil, sartorio y
semitendinoso con posible
afectación de la bursa
anserina”

Dolor localizado en la cara interna de la
rodilla (sensación de tensión)

Inflamación o tumefacción de la zona
junto a un **aumento del tono muscular**
en cara interna y anterior del muslo

Dificultad para pasar de sedente a bípedo,
subir escaleras o caminar mucho.

Disminuir dolor e inflamación

- Termoterapia en cara interna y posterior del muslo
- Crioterapia sobre tendón anserino
- Terapia combinada o US y corriente analgésica sobre el tendón anserino y tejido adyacente

Aumentar rango articular (flexibilidad)

- Masoterapia sobre musculatura isquiotibial (semitendinoso) y de la zona medial del muslo (grácil y aductores)
- Estiramientos osteomusculares de isquiotibiales, aductores y gemelos
- Movilidad pélvica

Incrementar fuerza muscular

- Ejercicios isométricos para estabilidad de pelvis (actividad puente)
- Ejercicios resistidos progresivos para cuádriceps y glúteo medio
- Ejercicios resistidos progresivos para isquiotibiales y aductores

Mejorar la funcionalidad de rodilla

- Potenciar actividades básicas de sedente a bípedo.
- Ejercicios funcionales para estiramiento de la cadena posterior
- Reeducación de la marcha con actividades simultáneas



Tendinitis – bursitis rotuliana

“Es la inflamación del
tendón rotuliano o
patelar con posible
afectación de la bursa
infrarotuliana”

Dolor localizado en la cara anterior
de la rodilla (por debajo de la rótula)

Aumento del tono muscular de
cuádriceps

Dificultad para flexionar y extender
completamente la rodilla

Disminuir dolor e inflamación

- Termoterapia en anterior del muslo
- Crioterapia sobre tendón rotuliano
- Terapia combinada o US y corriente analgésica sobre el tendón rotuliano y tejido blando adyacente

Aumentar rango articular (flexibilidad)

- Masoterapia sobre musculatura del cuádriceps
- Estiramientos osteomusculares de cuádriceps
- Deslizamientos articulares para rótula

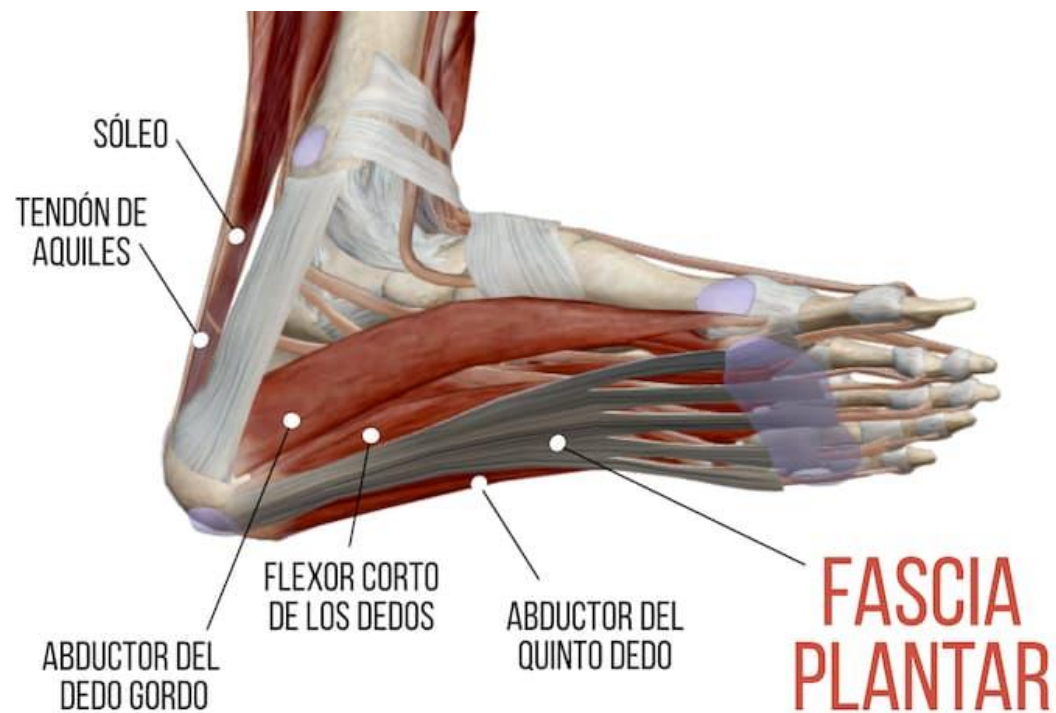
Incrementar fuerza muscular

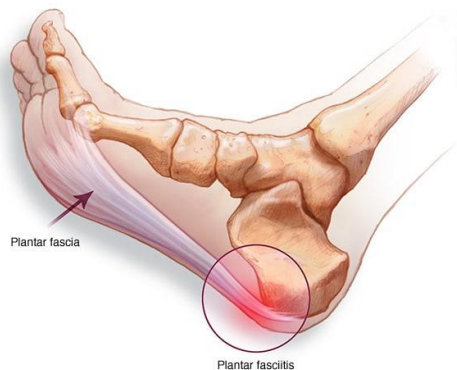
- Ejercicios isométricos (actividad puente, sentadilla)
- Ejercicios resistidos progresivos para cuádriceps e isquiotibiales
- Ejercicios resistidos para flexo extensión de rodilla (bandas o pesas)

Mejorar la funcionalidad de rodilla

- Actividades relacionadas a las ABVD o deportivas
- Reeducción de la marcha y subida/bajada de escaleras
- Cambios de sedente a bípedo

Articulación del pie (planta del pie)





“Inflamación del
tejido denso
(fascia) de la
planta del pie”

Dolor localizado en la planta del pie con predominio en el arco plantar interno.

Tumefacción con posible inflamación de la planta del pie.

Aumento del tono muscular en plantiflexores con afectación del **patrón de marcha (dolor al despegue)**.

Disminuir dolor e inflamación

- Termoterapia en musculatura de pantorrilla (gastrocnemios y sóleo)
- Crioterapia en puntos específicos
- Ultrasonido terapéutico en fascia plantar
- Corrientes analgésicas en fascia y talón

Aumentar rango articular (flexibilidad)

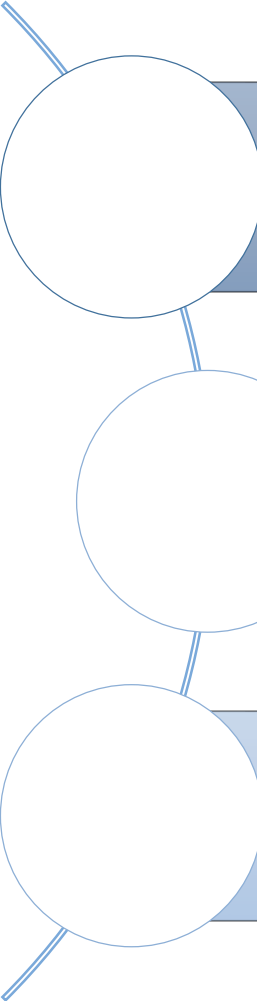
- Masoterapia sobre musculatura de la pantorrilla y sobre la fascia plantar
- Estiramientos osteomusculares de la musculatura plantiflexora y fascia plantar progresiva
- Movilizaciones articulares de tobillo, pie, retropié y antepié

Incrementar fuerza muscular

- Ejercicios progresivos para dorsiflexores (bandas)
- Ejercicios de soporte (sentadilla isométrica y zancada)
- Ejercicios resistidos progresivos para plantiflexores (bandas, ligas, etc.)

Mejorar la funcionalidad de pie

- Potenciar el apoyo unipodal alternado
- Potenciar saltos cortos
- Mejorar patrón de marcha y trote



1. EN LA EPITROCLEITIS SE VEN AFECTADOS LOS MÚSCULOS FLEXORES DE MUÑECA Y DEDOS Y EN LA EPICONDILITIS SE VEN AFECTADOS LOS MÚSCULOS EXTENSORES DE MUÑECA Y DEDOS.

2. LA TENDINITIS DE LA PATA DE GANSO ES UNA AFECCIÓN MUY COMÚN COMO CONSECUENCIA DE ALGUNA OTRA ALTERACIÓN EN RODILLA (ARTROSIS PRINCIPALMENTE) DEBIDO AL CAMBIO EN LA DINÁMICA MUSCULAR Y A LAS MODIFICACIONES POSTURALES.

3. EL PROTOCOLO DE REHABILITACION EN TENDINOPATIAS SE BASA EN EL USO DE CRIOTERAPIA, ULTRASONIDO Y ELECTROTHERAPIA ANALGÉSICA EN PUNTOS FOCALIZADOS DE DOLOR, MIENTRAS QUE LA TERMOTERAPIA SE INDICA EN MUSCULATURA ANEXA.

- <http://www.scielo.org.co/pdf/med/v19n1/v19n1a08.pdf>
- <https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-epicondilitis-epitrocleitis-revision-X0213932411435678>
- <https://scielo.isciii.es/pdf/medif/v13n1/tecnica.pdf>
- <https://www.medigraphic.com/pdfs/orthotips/ot-2014/ot143d.pdf>
- <https://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2016/rmc163s.pdf>
- <https://www.medigraphic.com/pdfs/pinar/rcm-2015/rcm152e.pdf>

Presente.

PREGUNTAS ACLARACIONES INTERVENCIONES



Proponga en grupo una estrategia para cada objetivo de la terapia física en cada uno de los siguientes casos clínicos:

1) Epicondilitis: Juan de 56 años es un policía en retiro que hace dos años comenzó a practicar frontón. Desde hace dos meses comenzó con un dolor en el codo derecho, siendo diagnosticado de epicondilitis derecha días después. Actualmente presenta dolor (EVA 6) en extensores de muñeca, bíceps braquial y trapecio superior; hipertonía en radiales y dificultades para pronosupinar el antebrazo.

2) Bursitis trocantérea: Mariana de 48 años es una ama de casa que fue diagnosticada de bursitis troncatérea derecha hace una semana probablemente debido a sus actividades rutinarias en su casa de 4 pisos. Actualmente presenta dolor (EVA 5) en TFL, musculatura glútea e isquiotibiales; hipertonía en TFL y marcha antiálgica.

3) Tendinitis anserina: Juliana de 65 años es una ex voleibolista que presenta un cuadro de artrosis de rodilla izquierda diagnosticada hace más de 10 años y hace 1 mes comenzó con dolores a nivel de la pata de ganso, tras lo cual fue diagnosticada de tendinitis anserina. Actualmente presenta dolor (EVA 8) en aductores, isquiotibiales y cuádriceps; hipotrofia moderada cuadricepital y problemas de equilibrio dinámico (tambaleo).

4) Fascitis plantar: Emiliano de 34 años es un profesor de danza que hace aproximadamente 2 semanas se le diagnosticó fascitis plantar derecha tras su primera participación en una maratón. Actualmente presenta dolor (EVA 6) en fascia plantar, gastrocnemios e isquiotibiales; hipertonía en gemelos, limitación para la dorsiflexión y disminución del equilibrio estático y dinámico.



MUCHAS GRACIAS

Presente.